

ΟΞΥΣ ΑΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Γενικά: Ο οξύς αορτικός διαχωρισμός (ΟΑΔ), είναι μια επείγουσα παθολογική οντότητα, που πρέπει να αναγνωριστεί άμεσα και να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία ψευδούς αυλού μεταξύ ενδοθηλίου και μέσου χιτώνα του τοιχώματος της αορτής, που επεκτείνεται σε άλλοτε άλλο μήκος του τοιχώματός της (συνήθως φθάνει μέχρι τις λαγόνιες αρτηρίες). Ο ΟΑΔ συνήθως επεκτείνεται ορθόδρομα, σπανίως δε αντίδρομα στη ροή του αίματος. Κύριες αιτίες θανάτου είναι η ελεύθερη ρήξη του ψευδούς ανευρυσματικού αυλού και η σοβαρή ισχαιμία ζωτικών οργάνων.

Προδιαθεσικοί παράγοντες: είναι η πλημμελώς ελεγχόμενη ΑΥ, οι συγγενείς ανωμαλίες του αορτικού τοιχώματος με εκφύλιση του μέσου χιτώνα (σύνδρομο Turner, Noonan και Ehlers-Danlos), το σύνδρομο Marfan, η διγλώχινα αορτική βαλβίδα, η ισθμική στένωση της αορτής, η αθηροσκληρυνση εφόσον υπάρχει ήδη αορτικό ανεύρυσμα, η κατ' επανάληψη και μακροχρόνια χρήση Φθοριοκινολονών, το κλειστό τραύμα του θώρακα, η εγκυμοσύνη, ο χειρουργικός τραυματισμός της αορτής κατά τις επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς, ο ΣΕΛ, η νόσος Αδαμαντιάδη-Behçet, το φαιοχρωμοκύττωμα, η σύφιλη, η χρήση κοκαΐνης, κ.ά.

Δύο ευρέως χρησιμοποιούμενες ταξινομήσεις του οξέος διαχωρισμού της αορτής υπάρχουν σήμερα: η κατά Stanford και η DeBakey.

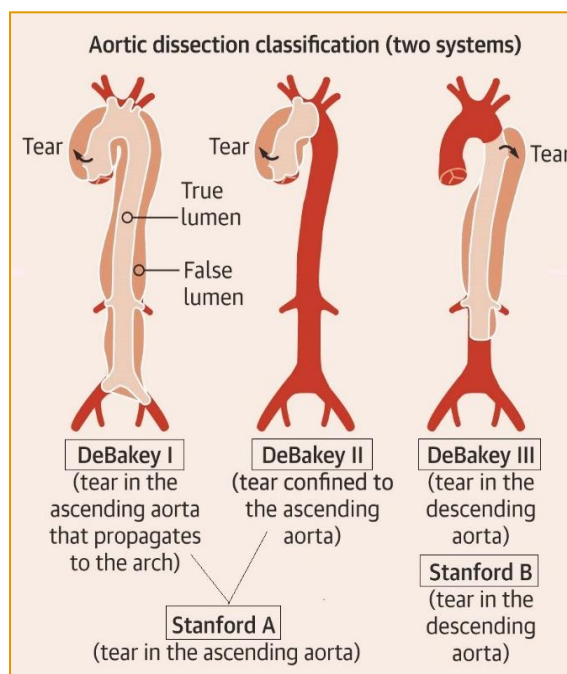
Η ταξινόμηση των αορτικών διαχωρισμών κατά **Stanford** είναι σαφώς απλούστερη, όσο και πρακτικότερη και διακρίνει δύο τύπους: τον **τύπο Α** που περιλαμβάνει κάθε περίπτωση όπου η ρήξη εντοπίζεται στην ανιούσα αορτή, ανεξάρτητα από την έκταση του διαχωρισμού και τον **τύπο Β** (όπου ο διαχωρισμός αρχίζει περιφερικά του σημείου έκφυσης της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας) που περιλαμβάνει όλους τους άλλους αορτικούς διαχωρισμούς.

Στο 70% των ασθενών ο ΟΑΔ αρχίζει από την ανιούσα αορτή αμέσως πιο πάνω από την αορτική βαλβίδα και από τα στόμια των στεφανιαίων αρτηριών, στο 10% ξεκινά από το αορτικό τόξο και στο 20% από το εγγύς τμήμα της κατιούσας θωρακικής αορτής.

Ο οξύς διαχωρισμός του αορτικού τοιχώματος μπορεί να συμβεί χωρίς να υπάρχει ανεύρυσμα. Στον τύπο Stanford Β οι ηλικίες εμφάνισης του ΟΑΔ είναι μεταξύ 60-70, ενώ στον τύπο Α 50-60 ετών. Το 1/3 των διαχωρισμών τύπου Β μακροχρόνια εξελίσσονται σε ανευρύσματα. Το 20% των ασθενών πεθαίνουν πριν φθάσουν στο νοσοκομείο.

Κλινική εικόνα: Ο ΟΑΔ χαρακτηρίζεται από σοβαρό, αιφνίδιο, οξύ, διαξιφιστικό πόνο στο θώρακα, στη ράχη, στην οσφύ ή σε ολόκληρο τον κορμό (αναλόγως του σημείου και της επέκτασης του ΟΑΔ) χωρίς μεταβολή των χαρακτήρων του, που ενίοτε συνδυάζεται με σοβαρή υπέρταση και πιθανόν ευρήματα υποάρδρευσης άλλων οργάνων, όπως παροδικό ή βαρύ ΑΕΕ (λόγω ΟΑΔ στο αορτικό τόξο), ΟΕΜ, ισχαιμία άνω ή κάτω άκρου και ΟΝΑ (ολιγουρία ή ανουρία), καθώς και με άλλες σοβαρές επιπλοκές, όπως αιμοθώρακα και αιμοπερικάρδιο με καρδιακό επιπωματισμό στις περιπτώσεις ρήξεως της ανιούσας αορτής.

Μπορεί – εκτός από το έντονο άλγος – να εμφανιστεί ταχυκαρδία (που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί), εφίδρωση, ναυτία, έμετος, λόξυγγας, αιφνίδιο βράγχος φωνής λόγω της επαφής με το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο, ίλιγγος, διαταραχές όρασης, πόνος και αιμωδία άνω άκρων ή ακόμα και ημιπληγία ή παραπληγία (οφειλόμενη σε έμφραξη μεσοπλευριών ή οσφυϊκών αρτηριών, που εμφανίζεται στο 2-4% των ασθενών με ΟΑΔ), αιματοουρία, κ.ά.



Διαφορική διάγνωση: OEM, στηθάγχη, παρόξυνση ΧΑΠ, πνευμονική εμβολή, σύνδρομο Dressler, συμπίεστική περικαρδίτιδα, πλευροχονδρίτιδα, μυοσκελετικό άλγος, πλευρίτιδα, πνευμοθώρακας, ΑΕΕ, έρπης ζωστήρας, κρίση ΓΟΠΝ, σπασμός οισοφάγου, νοσήματα και καταστάσεις από το πεπτικό με εικόνα οξείας κοιλίας, κολικός ουροφόρων οδών, κ.λπ.

Ευρήματα: Το ΗΚΓ εμφανίζει μη ειδικά ευρήματα. Στο 2-5% των ΟΑΔ (ιδίως τύπου Α) παρουσιάζεται εικόνα κατώτερου STEMI, ιδίως όταν ο ΟΑΔ φτάνει ως την έκφυση των στεφανιαίων αγγείων. Γενικά, υψηλός βαθμός υποψίας ανάπτυξης ΟΑΔ πρέπει να υπάρχει για όλους τους ασθενείς με οξύ θωρακικό άλγος που δε συνοδεύεται από σαφείς ΗΚΓφικές αλλοιώσεις ή σε ασθενείς με αιφνίδιο έντονο άλγος στη ράχη, την κοιλιά ή/και την οσφύ. Η ακτινογραφία θώρακος σπανίως είναι διαγνωστική· συχνά όμως απεικονίζει διεύρυνση του μεσοθωρακίου, αποτιτανώσεις στο αορτικό τόξο και πλευριτική συλλογή αριστερά. Αρνητική εξέταση D-Dimers (σελ. 406) αποτελεί ισχυρό στοιχείο αποκλεισμού του ΟΑΔ.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Εφαρμόζουμε συνεχές ΗΚΓφικό monitoring καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής παρέμβασής μας. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (*ΑΠ, σφύξεις, αναπνοές, SpO₂, θερμοκρασία*) και το επίπεδο συνείδησης με την GCS. Φροντίζουμε να μετρούμε την ΑΠ πάντοτε και από τους δύο βραχίονες. Έμφραξη της ανώνυμης αρτηρίας ή της αριστερής υποκλειδίου μπορεί να προκαλεί ψευδώς χαμηλή πίεση ή σημαντική διαφορά πίεσης στους δύο βραχίονες. Ελέγχουμε το σφυγμό στις μηριαίες αρτηρίες, άμφω.
2. Χορηγείται O₂ ρινικά, στα 2-4 lt/min ή και σε υψηλότερες ροές 6-10 lt/min, με απλή προσωπίδα ή μάσκα Venturi, εάν παραστεί ανάγκη, με στόχο επίπεδα SpO₂ > 90-92%
3. Τοποθετείται 3way φλεβική γραμμή μεγάλου εύρους (#16-18G) και στα δύο άνω άκρα.
4. Απαιτείται άμεση μείωση της ΑΠ και των σφύξεων, ώστε να περιοριστεί η έκταση του ΟΑΔ. Στόχος είναι η άμεση πτώση της ΣΑΠ σε επίπεδα μεταξύ 100-110 mmHg (ή της ΜΑΠ σε επίπεδα 60-75 mmHg) και του καρδιακού ρυθμού σε επίπεδα HR < 70 bpm.
5. Χορηγούμε 250 ml D₅W με 1 amp. **Nitrolingual** 25 mg, (10-50 μικροσταγόνες ~ ΑΠ).
6. Χορηγούμε **Λαβεταλόλη**, ήτοι: 20-50 mg Trandate (4-10 ml, iv-bolus) και εν συνεχεία 20-100 mg (4-20 ml Trandate) εντός 250 ml N/S, στάγδην, σε χρόνο 10-30 λεπτά ~ ΑΠ.
7. Εναλλακτικά, αντί Λαβεταλόλης, για επίτευξη β-αποκλεισμού (*μείωση των HR & BP*) χορηγούμε **Εσμολόλη** (Brevibloc), σε δόση 500 μg/kg ΒΣ, εντός 1 λεπτού, (*δηλαδή από τη φύσιγγα του Brevibloc των 100 mg/10 ml αναρροφούμε 3,5-5 ml, ήτοι 35-50 mg*). Κατόπιν, χορηγούμε Εσμολόλη σε στάγδην έγχυση, με ροή 4-30 mg/min, αναλόγως ΑΠ, με τιτλοποίηση δόσης και συνεχή έλεγχο της ΑΠ, λόγω μικρού χρόνου ημιζωής (9 min).
8. Σε επιγαστραλγία με ναυτία και εμέτους, χορηγούμε PPI (1 amp. Lordin) iv-bolus ή/και Σιμετιδίνη (1-2 amp. Tagamet), καθώς και 1 amp. Primperan ή Onda, σε 100 ml N/S.
9. Για τον επίμονο κι έντονο πόνο, που προκαλεί έντονο stress και επιτείνει την υπέρταση, τοποθετούμε 1 amp. Apotel 1 gr, εντός 100 ml N/S, να ληφθεί σε διάστημα 10 λεπτών.
10. Σε περίπτωση αφόρητου, επιδεινούμενου ή μη ανεχόμενου από τον ασθενή, θωρακικού ή κοιλιακού άλγους, επιχειρούμε τη χορήγηση Μορφίνης [1 amp. Μορφίνης 10 mg/1 ml αναμειγνύεται με 9 ml N/S και από το διάλυμα αυτό χορηγούμε 3 ml βραδέως ενδοφλεβίως ή αλλιώς 1 amp. Μορφίνης ή 1 amp. Τραμαδόλης (Tramal) 100 mg σε 100 ml N/S, εντός 30-45 λεπτών, με προσοχή στην αναπνευστική καταστολή και τη διακύμανση της ΑΠ].
11. Τοποθετούμε ουροκαθετήρα Foley (14-16 fr) για την κένωση της ουροδόχου κύστης και για τη μέτρηση του ισοζυγίου των υγρών. (*Η πλήρης ούρων ουροδόχος κύστη αποτελεί πιθανό παράγοντα αύξησης της ΑΠ, δυσφορίας και έντονου stress για τον οργανισμό*).
12. Τάχιστα διακομιδή – συνοδεία ιατρού – στο Νοσοκομείο και ενημέρωση για αναμονή στο ΤΕΠ. Κατά τη διακομιδή ο ασθενής βρίσκεται υπό συνεχές monitoring (ECG, BP, HR, RR και SpO₂) και σε ελεγχόμενη πάντοτε υπόταση και λοιπή θεραπευτική αγωγή.